Ascitis y percusión del abdomen

SEMIOLOGIA · Clase 26 · oleada, matidez desplazable, ecografía y timpanismo

1 · DE DÓNDE SALE EL LÍQUIDO: CUATRO PLANOS

Por qué se acumula
sube la presión venosa o cae la presión oncótica del plasma

por hipertensión portal en el
por presión venosa alta en el
por albúmina baja en el
por irritación en el

si aumenta aún más, pasa a

Plano hepático F9
cirrosis (la más frecuente), Budd-Chiari, hipertensión portal

Plano cardiaco F9
insuficiencia derecha, pericarditis constrictiva

Plano renal-endocrino F9
nefrótico, hipoalbuminemia, hipotiroidismo

Plano peritoneal F9
TBC, carcinomatosis, peritonitis, embarazo ectópico roto

también causa
la más a menudo causa
también causa
también causa

Ascitis
líquido libre patológico en la cavidad peritoneal; aumenta el abdomen y el peso, con oliguria

se explora por

2 · LÍQUIDO MATE, AIRE TIMPÁNICO

Percusión F12
líquido y órgano macizo suenan mate; víscera hueca con gas suena timpánico

el líquido pesa: cae al

Líquido declive, gas flota
en decúbito dorsal los flancos son mates y el centro timpánico

4 · ASCITIS A TENSIÓN Y SUS COMPLICACIONES

Ascitis a tensión F8
la presión eleva el diafragma y comprime la cava inferior y las venas renales

eleva el diafragma: causa
comprime las venas renales: causa

Insuficiencia respiratoria F8
diafragma elevado; derrame pleural

Insuficiencia renal F8
depleción del volumen intravascular y trastornos hidroelectrolíticos

obliga a
obliga a

Identificar la causa y prevenir el compromiso respiratorio, renal y electrolítico

sobre vísceras huecas es normal

3 · CUÁNTO LÍQUIDO Y QUÉ MANIOBRA LO MUESTRA

con mucho líquido se usa la

Oleada ascítica F1 · F2
borde cubital comprimiendo la línea media; palma en un flanco, golpes en el flanco opuesto

si la onda choca, hay

con volumen medio, gira al paciente

con poco líquido la percusión falla

Más de 1500 mL F3
oleada positiva y matidez en flancos de concavidad superior

500 a 1500 mL: matidez desplazable F3
oleada negativa; al girar al paciente la matidez migra al lado declive

Menos de 500 mL F3 · F4 · F6
se junta primero en la pelvis; la percusión suele ser insuficiente

en la inspección se ve
si la matidez migra, es
lo confirma la
si alterna mate y timpánico

Inspección
abdomen en batracio, ombligo protruido, circulación colateral

Líquido libre
el desplazamiento lo diferencia de una masa quística fija

Ecografía abdominal F5 · F7
el mejor examen: ve poco líquido cuando oleada y matidez son negativas

Tablero de ajedrez F5
matidez y timpanismo alternos: sugiere TBC peritoneal

confirma líquido; la causa guía
apoya el diagnóstico
cuando las otras son negativas
orienta la causa

El volumen decide la maniobra y la causa guía la conducta

5 · CUANDO SOBRA AIRE: HIPERTIMPANISMO Y JOBERT

sobre el hígado delimita el

Normal F12
timpanismo sobre vísceras huecas, más nítido en el espacio de Traube

si sobra aire, aparece el

Límite hepático superior
submatidez desde el 5.º espacio intercostal derecho

Hipertimpanismo F10 · F11 · F12
más aire, más tambor: meteorismo, obstrucción intestinal, neumoperitoneo

obliga a buscar la causa
si ocurre sobre el hígado
si suena timpánico, es

Signo de Jobert F10
timpanismo donde debería haber matidez hepática

Exceso de aire: buscar meteorismo, obstrucción o neumoperitoneo

indica

Aire libre bajo el diafragma: perforación de víscera hueca

mecanismo · causa · síndrome · concepto · técnica · diagnóstico · signo · desenlace · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología (09b, 09e) — teoría del docente